



Collection MedWIZ

6^e année médecine

DERMATOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Démarche diagnostique en dermatologie	8				
02	Acné	12				
03	Tumeurs cutanées malignes	14				
04	Psoriasis	16				
05	Leishmaniose cutanée	20				
06	Ulcère de jambe	24				
07	Eczéma allergique de contact	26				
08	Dermatite atopique	28				
09	Infections sexuellement transmissibles (IST)	32				
10	Urticaires chroniques	36				
11	Mycoses superficielles	38				
12	Ectoparasitoses	42				
13	Infections cutanées bactériennes	46				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
14	Dermatocorticoïdes	50				
15	Tâche rouge	52				
16	Toxidermie	54				
17	Prurit	58				
18	Alopécie acquise	60				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE EN DERMATOLOGIE (1)

I. RAPPEL ANATOMIQUE DE LA PEAU

1. 3 couches principales (extérieur → intérieur) :

- Épiderme : épithélium malpighien pluristratifié (kératinocytes 80%, mélanocytes, cellules de Langerhans, cellules de Merkel)
- Derme : tissu conjonctif (substance fondamentale, fibres, fibroblastes)
- Hypoderme : tissu adipeux

2. Annexes :

- Follicules pilo-sébacés, glandes sudorales (eccrines/apocrines), poils, ongles

3. Fonctions principales :

- Protection mécanique
- Anti-UV
- Thermorégulation
- Protection microbienne

II. EXAMEN CLINIQUE DERMATOLOGIQUE

1. Deux démarches :

- Analogique : rapide, reconnaissance d'un aspect caractéristique (risque d'erreur)
- Analytique (raisonnée) : recueil des données puis diagnostic (méthode recommandée)

2. INTERROGATOIRE

- Âge, profession, origine
- Antécédents personnels/familiaux
- Histoire de la maladie : mode de début, aspect initial, évolution
- Signes fonctionnels : prurit (maître symptôme), douleurs
- Médicaments, facteurs environnementaux

2. EXAMEN PHYSIQUE

- Patient déshabillé, lumière du jour
- Inspection de TOUTE la peau + plis, muqueuses, ongles, cheveux
- Palpation : relief, infiltration
- Vitropression : distingue érythème (s'efface) du purpura (ne s'efface pas)
- Curetage : analyse des squames, recherche lésion sous-croûte
- Dermographisme : stimulation linéaire
- Signe de Nikolsky : traction peau → décollement (bulleuses, Lyell)
- Dermatoscopie : lésions pigmentées

3. EXAMEN GÉNÉRAL ORIENTÉ

- Recherche d'adénopathies (mélanome), etc.

III. LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES

1. Caractérisation par :

Critères	Quelques précisions
Taille	mm à cm
Forme	ronde, ovale, irrégulière, etc.
Surface	lisse, squameuse, vésiculeuse, etc.
Couleur	érythémateuse, brune, violacée, etc.
Bords	nets, flous, découpés, etc.
Consistance	molle, ferme, indurée, élastique

2. Groupement

- Plaque (1-10 cm), placard (>10 cm), linéaire, annulaire, arcoforme, polycyclique, cocarde

3. Topographie / distribution

- Ubiquitaire ou localisée / généralisée
- Élective : ex. psoriasis coudes/genoux
- Symétrie fréquente

4. Phénomène de Koebner

- Apparition de lésions sur une zone traumatisée

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE EN DERMATOLOGIE (2)

IV. CLASSIFICATION DES LÉSIONS

A. LÉSIONS VISIBLES NON PALPABLES = MACULES

- Macules rouges : érythème (s'efface à la vitropression), macules vasculaires (partiellement), purpura (ne s'efface pas)
- Macules pigmentaires : mélaniques (chloasma, tache café-au-lait, mélanodermie) ou non mélaniques (tatouage, fer)
- Macules achromiques : hypochromie ou achromie (vitiligo, pityriasis versicolor)

B. LÉSIONS PALPABLES À CONTENU SOLIDE

- Papule : <1cm (verruque, urticaire, syphilides)
- Plaque : >1cm, coalescence de papules
- Nodule : >1cm, derme/sous-cutané
- Nouare : gros nodule étalé, douloureux (érythème noueux)
- Gomme : nodule → ramollissement → ulcération (infectieuse)
- Végétation : surélévation superficielle irrégulière

C. LÉSIONS PALPABLES À CONTENU LIQUIDE

- Vésicule : 1-2mm, sérosité claire (varicelle, eczéma)
- Bulle : >5mm à plusieurs cm, liquide clair/jaunâtre/hémorragique
- Pustule : contenu purulent (folliculaire ou non)

D. ALTÉRATIONS DE LA SURFACE

- Squames : argentées (psoriasis), poudreuses (pityriasis), grasses (dermite séborrhéique)
- Croûtes : coagulation d'exsudat
- Kératose/corne : épaissement corné
- Nécrose : mort tissulaire
- Pertes de substance :
 - érosion (superficielle, sans cicatrice)
 - ulcération (profonde, avec cicatrice)
 - ulcère (chronique)
 - fissure
 - escarre
 - chancre

E. MODIFICATIONS DE CONSISTANCE

- Atrophie : amincissement cutané
- Sclérose : induration, perte d'élasticité
- Œdème : signe du godet

F. LÉSIONS INTRIKUÉES

Association de plusieurs lésions (acné polymorphe, eczéma, etc.)

V. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

- Prélèvements microbiologiques : bactériens, fongiques (examen direct), parasitaires (shaving), viraux
- Biopsie cutanée : punch ou bistouri (ellipse) → indispensable pour tumeurs malignes
- Tests allergologiques : épicutanés (eczéma de contact), photobiologiques